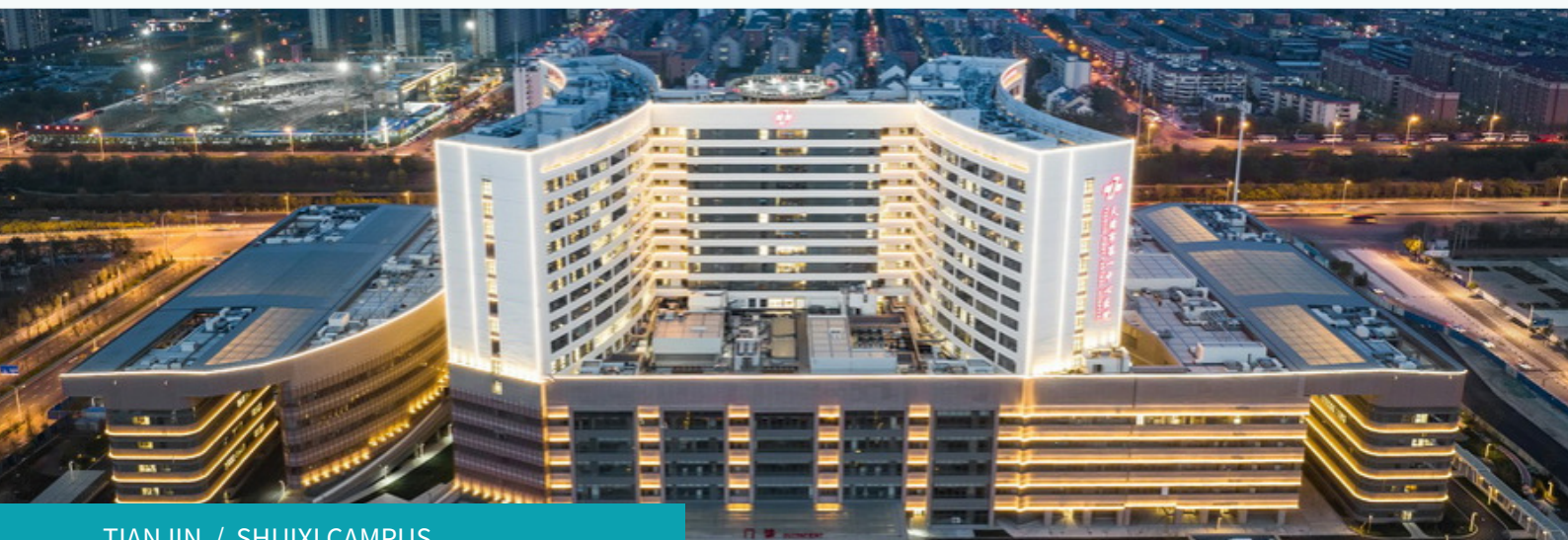


天津市第一中心医院 国际诊疗中心

Tianjin First Central Hospital
International Medical Center

以专业相伴，为健康远行

Expert Care, Every Step of Your Journey



TIANJIN / SHUOXI CAMPUS

自1996年起

专门从事国际诊疗 与特需医疗服务

高端定制查体

疾病诊疗与先进手术

固定病房与全程健康管理



诊疗场景示意

成人诊疗与全程健康管理

中文版 1.2 | 2026年9月

WELCOME / 按需要查阅

从了解中心到接受诊疗

CONTENTS

选择您关心的服务或疾病，点击目录即可跳转。

01 认识我们

认识国际诊疗中心	03
医院沿革与国际诊疗发展	04
以病情为基础的全程管理	05

02 重点服务

高端定制查体	06
胃肠镜相关查体	07
心血管系统相关查体	08
老年健康与多病共存管理	09
器官移植相关诊疗	10
胰岛细胞移植与移植后管理	11

04 技术与患者服务

重大手术与危重症支持	31
先进影像与功能检查	32
影像引导操作与精准诊断	33
医护照护与语言服务	34
从就诊申请到离院随访	35
住院环境与日常照护	36
就诊咨询与资料获取	37

03 按疾病系统查阅

心脏疾病	12
血管疾病与心血管风险管理	13
脑与神经系统疾病	14
消化道疾病与内镜治疗	15
肝胆胰疾病与复杂腹部手术	16
呼吸系统与胸部疾病	17
肾脏与泌尿系统疾病	18
骨关节与脊柱疾病	19
内分泌与代谢疾病	20
风湿与免疫性疾病	21
女性健康与生殖医学	22
眼耳鼻咽喉与口腔疾病	23
皮肤疾病与整形修复	24
乳腺甲状腺与其他外科疾病	25
肿瘤综合诊疗	26
血液系统疾病与细胞治疗	27
康复与疼痛管理	28
中医特色诊疗	29
感染性疾病与不明原因发热	30

认识国际诊疗中心

INTERNATIONAL MEDICAL CENTER



固定病房、常设医护团队，提供从疾病治疗到长期管理的连续服务。

诊疗场景为示意插画

1996

开始专门从事国际诊疗

约90个

外宾患者来源国家

2F / 16F

中心门诊与住院病区

天津市第一中心医院国际诊疗中心自1996年10月起专门从事国际诊疗及特需医疗服务，面向国际患者及国内有特需医疗需求的成人患者，提供健康评估、疾病诊治、住院治疗、康复指导与持续健康管理。

国际诊疗经验

近三十年来，中心已接诊来自约90个国家的外宾患者万余人，并曾承担2008年北京奥运会天津赛区、2025年上合组织天津峰会的涉外医疗保障任务。跨语言沟通、复杂疾病管理及不同文化背景下的照护，是中心日常医疗工作的重要组成。

中心直接参与治疗与管理

中心在水西院区设有门诊和固定住院病房，拥有常设医护团队。医生综合判断患者的疾病、既往治疗与个人需求，护士持续开展病情观察、治疗配合、生活照护和健康教育。专科治疗与日常疾病管理相互衔接，形成贯穿就诊前后的一套诊疗安排。

面向成人患者，提供三类查体、老年综合管理、各系统疾病诊治及移植相关评估；目前不接诊儿科。

医院沿革与国际诊疗发展

OUR HOSPITAL AND INTERNATIONAL CARE



天津市第一中心医院水西院区

天津市第一中心医院始建于1942年，逐步形成以器官移植、急救医学、耳鼻咽喉头颈外科为特色的综合诊疗体系。国际诊疗中心自1996年起专门从事国际诊疗及特需医疗服务，将专科诊疗与全程疾病管理相结合。

1942

● 医院前身天和医院创立。

1956

● 多家医疗机构及专家力量合并组建天津市第一中心医院。

1974

● 建立急性三衰抢救研究室及ICU病房，推动急救医学与危重症救治发展。

1994

● 获评三级甲等医院，同年成功开展原位肝移植手术。

1996

● 国际诊疗中心开始专门开展国际诊疗及特需医疗服务。

1998

● 建立器官移植外科，进一步发展器官移植诊疗体系。

今天 / 连续、个体化的国际诊疗

中心在水西院区设置门诊及固定住院病房，由常设医护团队提供健康评估、疾病治疗、康复指导与持续管理，并按病情评估团队式共同管理及资源配置。

医院沿革据医院官网公开资料；中心沿革据科室介绍。

以病情为基础的全程管理

CONTINUOUS TREATMENT AND DISEASE MANAGEMENT



诊疗场景示意

国际诊疗中心直接参与患者的治疗与疾病管理。中心首先完成整体评估，再根据病情复杂程度、治疗目标和患者需求，决定是否采用团队式共同管理，并随治疗进展调整专业人员与医疗资源配置。

01 中心综合评估

了解当前症状、既往诊断、用药、过敏史、既往手术及生活功能，核对已有影像、病理和检验资料。对多病共存或诊断尚不明确的患者，先理清主要问题与治疗优先次序，再安排必要的检查和专科评估。

02 专科与中心共同治疗

需要专科技术时，由相应专业团队完成手术、介入或专项治理；中心医护团队参与基础疾病处理、用药核对、营养与康复安排。不同专业围绕同一份病情信息沟通治疗目标，减少相互冲突的用药与重复检查。

03 治疗场所随需要调整

常规诊疗与照护可在中心门诊及固定病房进行。重大手术、病情危重或需要特殊防护时，患者可能转入医院公共ICU、专科监护病房或特殊治疗病区。符合转回条件后，可返回中心继续治疗和恢复；期间由相关团队衔接管理。

04 离院后继续跟进

出院时结合疾病和已实施的治疗，说明用药、复查、康复及需要警惕的症状。短期通过电话随访，长期通过邮箱和微信随访，频率依据病情确定。需要再次面诊、检查或当地医疗协助时，再制定相应安排。

02 / 重点服务

高端定制查体

PERSONALIZED HEALTH ASSESSMENT



诊疗场景示意

以个人病史、当前症状与健康目标为起点，由中心医生设计检查内容。对已有慢性病或正在服药的患者，查体同时关注疾病控制、用药适宜性和后续健康管理。

01 适合哪些需求

适用于希望系统了解健康状况、已有多项检查但缺少整体解释、需要复核长期用药，或希望在医生指导下安排疾病风险评估的成人。存在明确症状或异常结果时，将优先围绕临床问题开展诊疗。

02 检查如何安排

医生结合年龄、家族史、既往疾病、生活方式和已有资料，选择体格检查、实验室检测、超声及其他必要影像检查。可按需求进一步关注代谢、心血管、消化、肾脏、骨健康及女性健康等方向；需要多项连续评估时，可结合病情采用住院方式组织。

03 检查与用药管理相结合

在检查过程中核对现用处方药、非处方药、中药及保健品，评估疾病控制情况、药物相互影响及肝肾功能。确有需要时，由医生调整治疗方案，并说明调整理由、服用方法及复查要求。患者不应为查体自行停用长期药物。

04 形成可以继续执行的健康计划

汇总重要异常与需要优先处理的问题，解释检查结果，提供饮食、运动及生活方式指导。对需要专科治疗的发现，衔接进一步诊疗；对适合观察的问题，明确复查项目、时间和随访方式。

检查组合及住院安排均依据评估确定。高端定制查体不采用人人相同的固定检查清单。

02 / 重点服务

胃肠镜相关查体

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY CHECKUP



诊疗场景示意

以胃镜和结肠镜检查为核心，结合消化道症状、既往息肉或肿瘤病史、家族史及既往检查结果，评估食管、胃和结直肠健康。发现适宜处理的息肉或其他病变时，可在事先沟通与评估后衔接内镜治疗及病理检查。

01 检前评估与准备

医生核对心肺疾病、糖尿病、肝肾疾病、出血风险及既往麻醉情况，了解抗凝药、抗血小板药等用药。根据检查方式说明饮食、肠道准备及药物调整要求；镇静或麻醉方式须经相应评估后确定。

02 以胃肠镜检查为核心

根据评估安排胃镜、结肠镜或二者联合检查。内镜下观察黏膜与病变形态，必要时取组织进行病理检查；对需要进一步判断深度或来源的病变，可追加超声内镜等专项评估。

03 适宜病变的同期处理

对于符合内镜处理条件的息肉，可在充分知情同意后安排同期切除并送病理检查。病变较大、位置特殊、疑有深部侵犯，或患者用药与基础疾病增加操作风险时，可能需要分次治疗或转入外科评估。

04 病理解释与后续管理

检查后说明饮食与活动安排、出血等异常症状的观察要求。病理结果出具后，结合切除完整性、病变性质和既往病史制定复查计划；发现肿瘤或癌前病变时，衔接相应治疗团队。

能否同期切除取决于病变情况、术前准备、用药及操作条件，预约时请说明既往息肉和抗栓药使用情况。

心血管系统相关查体

CARDIOVASCULAR HEALTH ASSESSMENT



诊疗场景示意

围绕心血管危险因素、症状及既往疾病开展分层评估，兼顾血压、血脂、血糖、心脏结构、心律和心肌供血情况。需要进一步明确问题时，可衔接心血管专科检查和治疗。

01 基础风险与心脏评估

根据病史选择血压评估、血脂与代谢检查、心电图、超声心动图，以及动态心电图或动态血压监测等。对已有冠心病、心律失常、瓣膜病或心力衰竭的患者，同时评估疾病控制与药物治疗。

02 心肌灌注与代谢检查

有相应临床指征时，可安排ECT相关心肌灌注显像，包括静息或药物负荷检查，以了解心肌供血。PET/CT心肌代谢显像可用于特定临床问题下的代谢及心肌活性评估。两类检查提供的信息不同，由医生选择适合的项目。

03 冠状动脉进一步检查

当病史、症状及已有检查提示需要时，可安排冠状动脉CT等检查；必要时经专科评估进行冠状动脉造影，并讨论后续药物、介入或外科治疗。冠脉造影属于有创检查，不作为所有查体患者的常规项目。

04 持续风险管理

结合结果制定血压、血脂、血糖及体重管理目标，复核用药和运动安排。对需要长期治疗的患者，建立复查与随访计划，并说明出现胸痛、晕厥或明显呼吸困难时应及时就医。

ECT、PET/CT及冠脉造影按病情和检查指征选择，不作为无差别筛查组合。

老年健康与多病共存管理

OLDER ADULTS AND COMPLEX HEALTH NEEDS



诊疗场景示意

老年综合诊疗与多病共存管理是中心长期开展的重点服务。对于同时存在心血管、代谢、呼吸、神经或肾脏等疾病的患者，治疗需要兼顾疾病控制、日常活动能力、营养状态及患者自身的生活目标。

01 整体评估与治疗排序

综合了解主要疾病、近期变化、既往住院、睡眠与情绪、认知和生活自理情况。判断哪些问题需要优先治疗，哪些适合持续观察；必要时由相关专科共同讨论，形成可以执行的分阶段诊疗计划。

02 多种药物的统一核对

梳理不同医院和科室开具的药物，核对适应证、剂量与服药时间，关注重复用药、相互作用及肝肾功能变化。对容易发生低血压、低血糖、出血或跌倒的患者，结合个体状况调整治疗目标，并进行用药指导。

03 营养与功能维护

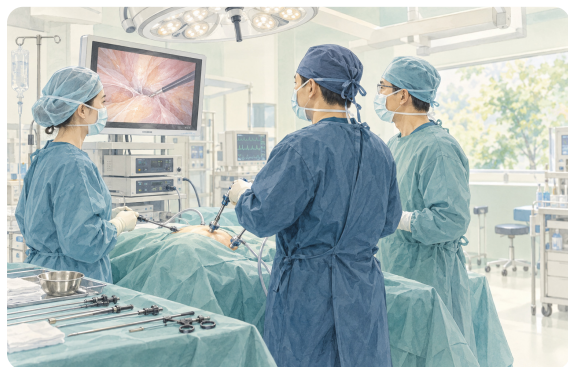
评估体重变化、食欲、吞咽、活动耐力、肌力及跌倒风险。根据情况安排营养支持、运动和康复指导，并与护理团队共同明确进食、转移、行走及生活照护中的协助需求。

04 住院治疗与长期照护衔接

需要集中检查、药物调整或短期病情观察时，可评估住院管理。离院前向患者及主要照护者说明疾病重点、药物变化和复查安排；长期随访关注症状、功能与生活质量，随病情调整管理方式。

器官移植相关诊疗

TRANSPLANT MEDICINE



诊疗场景示意

器官移植是天津市第一中心医院的重要技术领域。国际诊疗中心通过整体评估与团队式共同管理，将终末期器官疾病诊治、移植专科评估、围手术期治疗及后续长期管理相衔接；是否受理移植申请须逐例审核。

特色诊疗

器官移植与持续疾病管理

诊疗疾病

- 终末期肝脏疾病
- 终末期肾脏疾病
- 心、肺等终末期器官疾病
- 胰腺及小肠相关移植需求
- 多器官疾病及移植后问题

检查与评估

- 器官功能与原发病评估
- 感染、肿瘤及治疗耐受评估
- 移植专科与接诊条件审核

治疗项目与手段

1 器官移植相关诊疗

医院移植医学涉及肝、肾、心、肺、胰腺、小肠及联合移植等领域。具体治疗路径由移植专业团队逐例评估。

2 原发疾病与器官支持

对尚不适合或不需要移植的患者，继续开展原发疾病治疗、器官功能支持、血液净化及并发症管理。

3 围手术期共同管理

中心与移植团队衔接专科评估、手术及长期治疗，参与基础疾病、营养、康复和日常照护。

4 专科病区与长期复查

手术及早期恢复可能需在专科病房或移植监护病区完成；后续监测器官功能、感染和免疫抑制治疗。

治疗安排与后续管理

移植须符合中国法律法规、伦理规范及接诊管理要求。境外患者应先提供身份与完整病情资料；是否受理、治疗时机和场所均须审核。

胰岛细胞移植与移植后管理

ISLET CELL TRANSPLANTATION

胰岛细胞移植与长期移植随访是移植医学服务中的不同环节。前者需要针对糖尿病及相关条件进行专项评估，后者关注移植器官功能、用药、感染风险和日常健康。

特色诊疗

胰岛细胞移植



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 有胰岛细胞移植评估需求的糖尿病
- 移植后多种慢性疾病并存
- 移植后器官功能与用药问题

治疗项目与手段

01 胰岛细胞移植

医院开展胰岛细胞移植相关诊疗。由专科明确适用条件、技术路径、可能收益、风险及长期管理要求。

02 血糖与并发症管理

结合现用药物、血糖记录和并发症情况制定个体化方案；该技术并非适用于所有糖尿病患者的常规治疗。

03 移植后专项随访

按移植类型安排器官功能、相关影像、感染筛查及必要的药物浓度监测；功能异常及时衔接移植专科。

04 长期综合管理

同时关注血压、血糖、血脂、肾功能、骨健康和营养。免疫抑制剂等关键药物由负责团队调整。

检查与评估

糖尿病类型与胰岛功能 / 血糖波动与低血糖经历 / 并发症及治疗耐受性 / 既往移植与用药记录

治疗安排与后续管理

具体项目须符合中国法律法规及相应管理要求。请提前提供完整诊疗资料，由专业团队审核受理条件与开展安排。

心脏疾病

CARDIAC CARE



诊疗场景示意

围绕冠心病、心律失常、心力衰竭、心脏瓣膜病及肺动脉高压，结合药物、介入和外科技术选择治疗路径。对合并多种慢性疾病者，同时评估治疗耐受性与恢复需求。

特色诊疗

肺动脉去神经术（PADN）
专项评估 · 提前咨询

诊疗疾病

- 冠心病及复杂冠脉病变
- 心律失常
- 心力衰竭
- 心脏瓣膜病
- 部分成人先天性心脏病
- 肺动脉高压及相关右心功能障碍

检查与评估

- 心电与心律监测
- 超声心动图与血流动力学评估
- 冠脉造影、IVUS、OCT、FFR

治疗项目与手段

1 冠脉介入与搭桥

球囊扩张、支架植入及适宜钙化病变的旋磨；需要外科治疗时评估冠状动脉搭桥、微创、机器人辅助或杂交治疗。

2 消融与起搏治疗

电生理评估、导管射频消融、永久起搏器；符合条件时评估植入式心律转复除颤器（ICD）及心脏再同步化治疗（CRT）。

3 瓣膜与结构性心脏病治疗

瓣膜修复或置换、适宜的微创或机器人辅助手术；特定主动脉瓣病变可评估TAVI/TAVR，部分先心病可评估封堵或手术。

4 肺动脉高压与PADN专项评估

开展病因、心功能及血流动力学评估。部分符合条件的患者可进一步评估肺动脉去神经术（PADN，射频消融）的适用性；结合病型、既往治疗及项目条件决定方案，请提前咨询。

5 药物与心功能管理

结合心功能、容量状态及基础疾病制定长期药物治疗、危险因素控制和心脏康复计划。

治疗安排与后续管理

治疗后复核抗栓等用药，观察切口与并发症，安排心功能复评和运动恢复。复杂手术或术后需要时，使用相应监护病区。

血管疾病与心血管风险管理

VASCULAR CARE

血管疾病诊疗覆盖主动脉、外周动脉与静脉系统。高血压、血脂异常和整体心血管风险管理单独开展，并与心脏、肾脏及代谢疾病治疗衔接。

特色诊疗

经导管去肾交感神经术（RDN）



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 主动脉瘤与主动脉夹层
- 外周动脉狭窄或闭塞
- 静脉曲张与静脉血栓
- 部分肺栓塞
- 糖尿病足及复杂创面
- 高血压、血脂异常

治疗项目与手段

01 主动脉与外周动脉治疗

主动脉腔内隔绝、球囊扩张、支架植入及部分斑块处理；按病变评估开放、杂交及复杂主动脉根部或弓部手术。

02 静脉与血栓治疗

静脉曲张可选择腔内激光、硬化等方法；血栓、静脉狭窄及部分肺栓塞可评估抗凝、导管溶栓、介入或滤器。

03 血运重建与创面修复

结合供血、神经病变及感染，开展适宜的血运重建、局部处理、血糖管理与康复。

04 高血压介入治疗：RDN

对符合适应证的高血压患者，可开展经导管去肾交感神经术（RDN），包括肾动脉射频消融。术前评估血压、既往用药、肾功能及肾动脉条件；术后持续监测血压、调整用药并开展长期管理。

检查与评估

血管影像与供血评估 / 血栓和出血风险评估 / 动态血压与心肾功能 / 代谢及危险因素评估

治疗安排与后续管理

围绕出血、血栓复发、伤口恢复和活动能力安排复查，并管理血压、血脂与代谢风险。疑继发性高血压时进一步查因；治疗方法结合血管解剖、病变及整体状况确定。

脑与神经系统疾病

NEUROLOGICAL CARE



诊疗场景示意

诊疗范围包括脑血管病、脑及脊髓肿瘤、癫痫、运动障碍、认知障碍、周围神经病及相关功能问题。根据病因和病变特点，结合药物、介入、显微外科与康复治疗。

特色诊疗

重大手术后的监护与康复

诊疗疾病

- 脑血管病与脑动脉瘤
- 脑、颅底及脊髓肿瘤
- 癫痫与帕金森病等运动障碍
- 三叉神经痛
- 认知障碍、头痛与眩晕
- 周围神经及睡眠相关问题

检查与评估

- 脑血管影像与灌注评估
- 视频脑电图、肌电图
- 认知与神经功能评估
- 必要的术中电生理监测

治疗项目与手段

1 脑血管介入与手术

适宜患者可评估动脉瘤介入或显微夹闭、颈动脉内膜剥脱及颅内血管搭桥；同时开展卒中病因与危险因素管理。

2 显微外科与神经内镜

脑、颅底及脊髓肿瘤可评估显微切除、神经内镜或立体定向手术，复杂颅底病变由相关专业共同处理。

3 功能性疾病治疗

结合病情评估药物、脑深部电刺激、微血管减压等方案，兼顾症状控制和神经功能保护。

4 神经康复与长期管理

围绕运动、吞咽、语言、认知和日常活动能力安排治疗后康复，持续评估慢性神经症状。

治疗安排与后续管理

重大神经外科手术后可能需使用医院公共ICU或专科监护病房进行特殊治疗。急性卒中应立即进入急救流程。

消化道疾病与内镜治疗

DIGESTIVE AND ENDOSCOPIC CARE

针对食管、胃、肠道及部分胰胆疾病，将症状评估、内镜检查、组织病理和微创治疗相结合。对需要外科手术或肿瘤综合治疗的情况，及时衔接相关团队。

特色诊疗

EMR ESD ERCP POEM



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 反流、腹痛及排便异常
- 消化道出血与狭窄
- 胃肠息肉与早期肿瘤
- 消化道黏膜下肿物
- 贲门失弛缓症
- 部分胰胆及小肠疾病

治疗项目与手段

01 息肉与早期病变切除

适宜病变可评估内镜黏膜切除术（EMR）、内镜黏膜下剥离术（ESD）；黏膜下肿物可评估挖除、隧道或全层切除。

02 胰胆内镜与介入

内镜逆行胰胆管造影（ERCP）相关取石、引流、支架；超声内镜检查及适宜的穿刺、引流操作。

03 功能与急症内镜治疗

贲门失弛缓症可评估经口内镜肌切开术（POEM）；按病情安排内镜止血、消化道狭窄支架等处理。

04 胃肠外科与综合治疗

对不适合内镜处理的肿瘤、胃肠急症及其他外科病变，评估腹腔镜或开放手术，并衔接肿瘤治疗。

检查与评估

胃镜、结肠镜及组织病理 / 超声内镜 / 适宜的小肠胶囊内镜 / 检验、影像与营养评估

治疗安排与后续管理

切除后依据病理判断完整性与后续治疗需要；持续安排饮食、营养恢复和复查。具体内镜术式需结合病变深度、部位和风险选择。

肝胆胰疾病与复杂腹部手术

HEPATOBIILIARY AND PANCREATIC CARE



诊疗场景示意

针对肝脏肿瘤、胆道及胰腺疾病、肝胆管结石、门静脉高压及脾脏相关问题，结合器官功能、病变范围和患者整体状况制定治疗方案。复杂病例可同时讨论手术、内镜、介入及系统治疗。

特色诊疗

腹腔镜胰十二指肠切除术 Whipple

诊疗疾病

- 肝脏肿瘤
- 胰腺癌及胰头、壶腹周围病变
- 肝胆管结石与胆道疾病
- 胰腺炎及相关并发症
- 门静脉高压与脾脏相关问题

检查与评估

- 肝储备功能评估
- 三维影像规划与术中超声
- 肿瘤范围及血管关系
- 营养、感染与手术耐受性

治疗项目与手段

1 腹腔镜Whipple手术

针对胰腺癌及其他符合适应证的胰头、壶腹周围病变，可开展腹腔镜胰十二指肠切除术。结合肿瘤范围和血管关系决定方案。

2 复杂肝切除与血管重建

适宜患者可评估腹腔镜及荧光导航；涉及主要血管侵犯或癌栓时，进一步评估复杂切除和血管重建的可行性。

3 多镜联合与胆道治疗

依据结石部位、胆道结构及既往手术，选择腹腔镜、胆道镜、消化内镜或多镜联合；胰腺炎按病情安排引流与器官支持。

4 局部与系统治疗

肝胆胰肿瘤可结合病情讨论消融、介入与系统治疗的顺序，衔接术后抗肿瘤治疗。

治疗安排与后续管理

围手术期关注肝功能、血糖、营养、感染与血栓风险。重大手术可能需在公共ICU或专科重症病房完成早期治疗。

呼吸系统与胸部疾病

RESPIRATORY AND THORACIC CARE

围绕肺部结节、肺癌、气道及胸膜疾病、慢性呼吸疾病和睡眠呼吸问题，结合影像、肺功能、内镜取材和病理信息，选择观察、药物、介入或手术治疗。

从明确诊断到个体化治疗



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 肺结节与肺癌
- 气道狭窄与胸膜疾病
- 食管及纵隔肿瘤、胸腺疾病
- 慢性阻塞性肺疾病与哮喘
- 睡眠呼吸障碍

治疗项目与手段

01 胸腔镜与机器人辅助手术

可评估单孔胸腔镜、机器人辅助等微创技术；适宜中央型肺癌可讨论支气管或血管袖式成形手术。

02 气道介入与胸膜诊疗

支气管镜活检、超声支气管镜引导针吸活检；气道狭窄可评估球囊扩张或支架，胸膜病变可行内科胸腔镜及活检。

03 食管与纵隔外科

食管、纵隔、胸腺及部分胸膜病变可评估胸腔镜或其他手术，兼顾呼吸功能和营养状况。

04 慢性疾病与睡眠治疗

开展药物及吸入装置指导，结合睡眠监测评估相应治疗，关注夜间缺氧与心血管影响。

检查与评估

胸部影像与肺功能 / 支气管镜、EBUS-TBNA / 胸腔镜及组织病理 / 呼出气一氧化氮、睡眠监测

治疗安排与后续管理

肺结节处理结合影像变化和风险选择随访、取材或手术。肿瘤治疗依据分期与病理，治疗后衔接呼吸康复和复查。

肾脏与泌尿系统疾病

RENAL AND UROLOGICAL CARE



诊疗场景示意

将肾功能保护、泌尿系统结构性疾病和需要手术的病变综合考虑。诊疗范围包括急慢性肾脏病、尿路结石、泌尿肿瘤、前列腺疾病及排尿功能障碍。

治疗与管理相结合

诊疗疾病

- 急慢性肾脏病与肾功能异常
- 尿路结石
- 肾、膀胱及前列腺肿瘤
- 前列腺增生与排尿障碍
- 女性压力性尿失禁
- 男性生殖相关问题

检查与评估

- 肾功能、尿液与影像检查
- 必要的肾穿刺病理
- 排尿功能与残余尿评估
- 精液及生殖相关检查

治疗项目与手段

1 血液净化与肾脏治疗

按病情安排血液透析、血液透析滤过、连续血液净化、血浆置换及适宜的免疫吸附；腹膜透析可评估置管及管理。

2 泌尿肿瘤手术

针对肾、膀胱及前列腺肿瘤，可评估机器人辅助、腹腔镜或开放手术，兼顾肿瘤控制与器官功能。

3 结石与排尿障碍治疗

结石可评估输尿管软镜、经皮肾镜；前列腺增生按病因选择药物或手术，压力性尿失禁可评估微创吊带。

4 男性生殖显微技术

适宜患者可评估显微精索静脉手术、睾丸取精等技术，并与生殖医学团队衔接。

治疗安排与后续管理

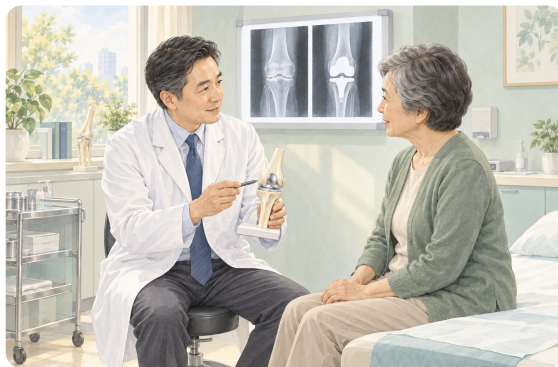
治疗同时关注肾功能、感染与排尿状况。肾移植相关诊疗见第10页，具体术式结合病变部位、分期及整体耐受性确定。

骨关节与脊柱疾病

BONE JOINT AND SPINE CARE

围绕疼痛、活动受限和结构性损伤，评估保守治疗、微创操作或手术的适用性。对合并心肺疾病、糖尿病或骨质疏松的患者，同时安排围手术期风险管理与功能恢复。

从明确诊断到个体化治疗



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 严重髋膝关节疾病
- 股骨头坏死
- 肩膝关节相关损伤
- 颈腰椎间盘突出及脊柱退变
- 骨折及手足外科疾病
- 拇外翻

治疗项目与手段

01 关节置换

结合病变与活动需求，评估人工髋关节、膝关节或髌股关节置换；治疗前明确功能目标与康复计划。

02 关节镜治疗

肩膝关节病变可评估关节镜等适宜方案，兼顾关节稳定性、术后保护和运动训练。

03 脊柱微创与融合技术

按神经功能、影像与疼痛来源，评估显微镜辅助、内镜、微创融合或其他手术。

04 骨折与手足外科

开展骨折、手足相关评估与治疗，适宜患者可评估拇外翻微创手术。

检查与评估

骨关节影像与功能评估 / 疼痛来源与神经功能 / 骨健康及围手术期风险

治疗安排与后续管理

老年患者同时管理营养、骨质疏松和内科基础疾病；术后关注伤口、血栓、负重及步行训练。手术决定需结合症状和功能，不能仅凭影像。

内分泌与代谢疾病

ENDOCRINE AND METABOLIC CARE



诊疗场景示意

围绕糖尿病、甲状腺、垂体、肾上腺及骨代谢等问题开展评估和治疗。将实验室检测与症状、用药、营养和生活方式结合，形成长期管理方案。

治疗与管理相结合

诊疗疾病

- 糖尿病及相关并发症
- 甲状腺功能异常与结节
- 垂体、肾上腺及甲状旁腺疾病
- 肥胖与血脂、尿酸异常
- 骨质疏松与骨代谢问题

检查与评估

- 血糖波动与低血糖风险
- 激素、超声、CT或MRI
- 肾脏、眼底、神经及足部评估
- 骨密度及继发因素检查

治疗项目与手段

1 血糖与并发症管理

结合现有治疗、血糖波动和低血糖风险调整方案；合并感染、手术或急性疾病时开展相应监测与治疗。

2 内分泌专项治疗

按病种开展药物治疗，需要手术、核素或其他专项治疗时，由相应团队共同制定路径。

3 体重与代谢管理

结合饮食、活动、睡眠、合并疾病和药物因素，安排生活方式指导及有指征的药物治疗。

4 骨健康维护

制定药物、营养与运动方案；已有骨折或活动障碍时，衔接骨科、康复及护理管理。

治疗安排与后续管理

随病情变化复核用药与治疗目标，同时关注心血管、肝脏和肾脏风险。胰岛细胞移植属于专项评估内容，见第11页。

风湿与免疫性疾病

RHEUMATOLOGY AND IMMUNE CARE

关节疼痛、皮疹、反复发热、口眼干燥或多个器官同时受累，可能需要系统的免疫相关评估。治疗重点包括明确疾病活动度、保护受累器官、控制症状及减少长期治疗相关风险。

从明确诊断到个体化治疗



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 类风湿关节炎与脊柱关节炎
- 系统性红斑狼疮与干燥综合征
- 系统性血管炎、炎性肌病
- IgG4相关疾病
- 痛风、骨质疏松
- 部分自身免疫性肝病

治疗项目与手段

01 个体化药物治疗

依据病种、活动度、器官受累和既往治疗，选择免疫调节等药物，持续评估疗效。

02 生物制剂与靶向治疗

符合条件时评估相应生物制剂或其他靶向药物，结合感染风险及治疗反应调整。

03 复杂病例专项技术

部分病例可评估免疫吸附等方法，具体实施条件由相关专业团队确定。

04 器官保护与功能维护

受累器官由相应专业共同管理，并安排关节保护、活动训练和围手术期用药衔接。

检查与评估

自身抗体与疾病活动度 / 关节超声、MRI等影像 / 肺、心、肾及神经受累评估

治疗安排与后续管理

长期监测感染、血细胞、肝肾功能、骨健康和药物不良反应。诊断需综合临床表现，不能仅依据某一项抗体结果。

女性健康与生殖医学

WOMEN'S HEALTH AND REPRODUCTIVE MEDICINE



诊疗场景示意

围绕女性不同生命阶段的健康需要，提供妇科疾病、宫颈病变、内分泌与围绝经期健康、盆底问题及生殖相关评估。对合并其他系统疾病的患者，结合整体病情安排诊疗。

治疗与管理相结合

诊疗疾病

- 子宫、卵巢等良恶性病变
- 宫颈病变
- 月经及卵巢功能异常
- 围绝经期与盆底问题
- 不孕不育
- 孕产期合并内外科疾病

检查与评估

- 宫颈HPV、细胞学与阴道镜
- 必要的活检与激素检查
- 超声及相关影像
- 双方生殖评估与卵泡监测

治疗项目与手段

1 妇科微创手术

宫腔镜、腹腔镜及3D腹腔镜相关诊疗；妇科肿瘤结合病理和分期安排手术或系统治疗。

2 宫颈、围绝经期及盆底治疗

结合检查和整体健康状况制定治疗与随访，需要保留生育功能时提前讨论可行性。

3 辅助生殖技术

医院开展夫精人工授精、体外受精与胚胎移植、卵胞浆内单精子注射及胚胎冷冻相关技术。

4 孕产期共同管理

高风险因素或合并内外科疾病时，中心与产科评估管理场所；孕期检查、分娩和特殊监护按产科要求安排。

治疗安排与后续管理

辅助生殖须符合中国法律法规及专业管理要求，境外患者应提前咨询受理条件。中心目前不接儿科；女性私密整形见第24页。

眼耳鼻咽喉与口腔疾病

EYE ENT AND ORAL CARE

这些疾病常影响视力、听力、呼吸、吞咽和日常交流。诊疗既关注局部病变，也考虑糖尿病、抗栓用药及其他基础疾病对手术与恢复的影响。

特色诊疗

鼻部功能性手术与鼻内镜治疗



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 白内障、青光眼、眼底及角膜疾病
- 干眼与泪道问题
- 慢性鼻炎、鼻甲肥大、鼻中隔偏曲
- 鼻窦疾病及部分鼻颅底病变
- 听力、眩晕、睡眠呼吸与头颈病变
- 牙体牙髓、牙周、颌面外伤及肿瘤

治疗项目与手段

01 眼科手术与治疗

微切口白内障超声乳化及人工晶体植入、青光眼手术、角膜移植、玻璃体切除及注药、视网膜等激光治疗。

02 耳鼻咽喉与鼻颅底手术

耳显微外科、鼻内镜及鼻颅底相关手术；适宜患者可评估脑脊液鼻漏修补、眶减压及联合神经外科处理的经鼻病变。

03 鼻炎相关与鼻部功能性手术

慢性鼻炎、鼻甲肥大、鼻中隔偏曲及鼻窦疾病，结合症状、鼻内镜及必要影像制定方案。规范药物治疗后仍有明显症状且符合手术指征者，可评估鼻甲相关功能性手术、鼻中隔矫正及鼻内镜下鼻腔鼻窦手术，兼顾通气与功能保护。

04 口腔修复与外科

牙体牙髓、牙周及黏膜病治疗，义齿修复、种植牙及正畸评估；颌面骨折、肿瘤及唾液腺病变可安排外科诊疗。

检查与评估

OCT、眼底造影、视野与超声 / 听力、平衡、睡眠及内镜 / 口腔与颌面相关检查

治疗安排与后续管理

合并基础疾病时，先评估操作条件、抗栓用药与感染风险。术后明确用药、进食、伤口保护和复查；多阶段修复或长期注药，应提前讨论停留时间及当地随访。

皮肤疾病与整形修复

DERMATOLOGY AND RECONSTRUCTIVE CARE



诊疗场景示意

服务涵盖慢性皮肤病、瘢痕、复杂创面、组织缺损及医学整形需求。整形治疗同时考虑功能、外观、个人诉求与手术风险，注重隐私保护和充分沟通。

特色诊疗

面部整形与女性私密整形

诊疗疾病

- 湿疹、银屑病与白癜风
- 大疱性疾病与真菌病
- 色素、血管性病变及皮肤肿物
- 烧伤后瘢痕与复杂创面
- 面部整形及外观改善需求
- 女性私密整形与修复需求

检查与评估

- 皮肤病理、免疫及真菌检查
- 软组织、瘢痕与功能评估
- 整形目标与手术风险沟通

治疗项目与手段

1 皮肤病药物与光电治疗

结合疾病类型选择药物、紫外线光疗及适宜的激光治疗。

2 瘢痕与组织修复

压力与药物治疗、瘢痕切除松解、植皮、皮瓣及组织扩张等，兼顾创面愈合与活动功能。

3 面部医学整形

依据面部结构、皮肤软组织和个人目标评估方案，明确改善范围、瘢痕、恢复过程与风险。

4 以女性为主的私密整形

围绕形态、舒适度或修复需要，结合生育史、局部病变和盆底情况制定方案；必要时联合妇科、泌尿与盆底专业。

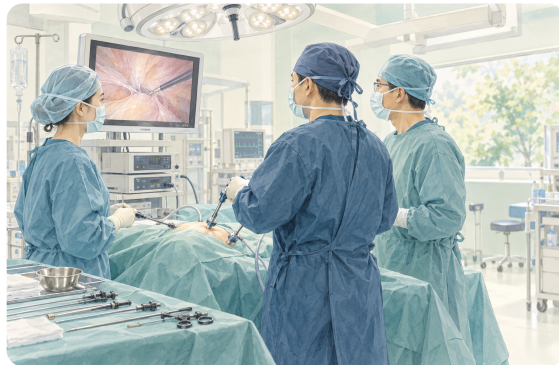
治疗安排与后续管理

重视隐私保护和充分沟通。整形效果与个体条件、治疗方式及恢复过程有关，具体方案需面诊后确定。

乳腺甲状腺与其他外科疾病

BREAST THYROID AND GENERAL SURGERY

对于乳腺、甲状腺、腹壁疝及肛肠等问题，先明确病变性质与治疗需求，再结合基础疾病选择观察、药物或手术。相关内容独立列示，便于按疾病查阅。



诊疗场景示意

从明确诊断到个体化治疗

诊疗疾病

- 乳腺结节、肿块与肿瘤
- 甲状腺结节及需外科处理的疾病
- 腹股沟疝、切口疝等腹壁疝
- 肛肠疾病
- 其他腹部外科问题

治疗项目与手段

01 乳腺疾病手术与综合治疗

依据病理、疾病阶段及整体状态制定方案，并衔接肿瘤治疗和整形修复。

02 甲状腺外科治疗

根据病变明确切除范围，关注重要结构保护与术后功能；需要核素或内分泌治疗时进一步联合评估。

03 腹壁疝修补

结合缺损部位、大小、复发与既往手术情况，选择腹腔镜或开放修补。

04 肛肠及其他外科治疗

明确便血、肛周疼痛或排便异常的病因后，讨论保守或手术方案；胃肠急症按病情安排诊疗。

检查与评估

超声、乳腺摄影及必要取材 / 甲状腺功能与细胞、组织学 / 缺损范围及既往手术评估 / 肛肠专科检查

治疗安排与后续管理

术前处理慢性咳嗽、排尿困难、营养和其他影响恢复的因素，术后说明活动与复查安排。明显急性疼痛或出血需及时就医。

肿瘤综合诊疗

COMPREHENSIVE CANCER CARE



诊疗场景示意

肿瘤治疗首先需要明确病理诊断、疾病范围和患者整体状况。中心结合肿瘤及相关专科资源，衔接手术、系统治疗、放射治疗和适宜的局部治疗，并持续处理治疗中的症状与基础疾病。

特色诊疗

手术 药物 放疗 局部治疗

诊疗疾病

- 肺部及乳腺恶性肿瘤
- 消化道与肝胆胰肿瘤
- 其他实体肿瘤
- 复发、转移及复杂治疗需求
- 治疗相关症状与营养问题

检查与评估

- 病理会诊与分期复核
- 必要的补充取材及标志物
- 影像、既往疗效和耐受评估

治疗项目与手段

1 系统性药物治疗

结合病理类型、批准适应证、分子检测和器官功能，评估化疗、靶向及免疫治疗，并监测疗效与不良反应。

2 精准放射治疗

可评估IMRT、VMAT、IGRT、SRS、SBRT及适宜的术中放疗等技术。

3 手术与局部治疗

按病情衔接手术、影像引导消融、介入或核医学相关治疗，综合讨论治疗顺序。

4 症状控制与生活质量

将疼痛、恶心、营养不足、感染和其他治疗问题纳入管理，结合需求安排心理支持与康复。

治疗安排与后续管理

方案需综合分期、既往治疗反应和患者目标。随访关注疗效、复发风险与功能；部分治疗需在相应专科病区完成。

血液系统疾病与细胞治疗

HEMATOLOGY AND CELL THERAPY

诊疗范围包括贫血、血细胞减少、出凝血异常、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤及骨髓增生异常或增殖性疾病。治疗依据疾病分型、风险分层、既往治疗和整体身体状况制定。

特色诊疗

CAR-T与造血干细胞移植



诊疗场景示意

诊疗疾病

- 贫血与血细胞减少
- 出凝血异常
- 白血病与淋巴瘤
- 多发性骨髓瘤
- 骨髓增生异常或增殖性疾病

治疗项目与手段

01 系统与支持治疗

根据病种和风险选择药物及支持治疗，处理感染、贫血、出血和器官功能问题。

02 造血干细胞移植

医院具备自体 and 异基因造血干细胞移植相关技术，包括适宜的相合与半相合移植。

03 CAR-T细胞治疗

开展CAR-T相关工作。具体产品、适应证、项目性质、受理条件及所需资料，须在来院前由专业团队明确。

04 老年血液病管理

结合多病共存、营养、活动能力及治疗耐受性，安排治疗强度、复查与长期照护。

检查与评估

血液与骨髓检查 / 疾病分型与风险分层 / 微小残留病等疗效监测 / 器官功能与感染评估

治疗安排与后续管理

CAR-T和造血干细胞移植须符合中国法律法规及项目要求。部分阶段需进入特殊移植舱、层流病房或监护病区；请提前咨询。

康复与疼痛管理

REHABILITATION AND PAIN CARE



诊疗场景示意

康复和疼痛治疗可贯穿疾病恢复与长期管理。诊疗关注疼痛来源、活动能力和生活目标，通过药物、训练、物理治疗及有指征的介入或微创操作，帮助患者改善功能。

治疗与管理相结合

诊疗疾病

- 卒中后及其他神经功能障碍
- 骨折、骨关节手术后恢复
- 烧伤修复后功能问题
- 颈肩腰腿痛及脊柱相关疼痛
- 三叉神经痛与带状疱疹后神经痛
- 部分顽固性疼痛

检查与评估

- 运动、日常活动与功能评估
- 疼痛来源及神经体征
- 影像与既往治疗反应

治疗项目与手段

1 功能康复

物理治疗、作业治疗、手法及物理因子治疗，按需使用矫形器，并与相关专科衔接复查。

2 疼痛微创技术

按适应证评估神经阻滞、射频、脊柱内镜；骨质疏松性椎体骨折可评估椎体成形。

3 难治性神经痛治疗

根据病因评估药物、微球囊压迫、射频或脊髓电刺激，兼顾功能、风险及后续维护。

4 回归日常生活

说明安全行走、转移、功能训练与辅助器具使用，衔接院内训练和居家管理目标。

治疗安排与后续管理

康复强度随疼痛、功能和耐力变化调整；长期卧床或重症恢复者同时关注营养和皮肤。治疗目标应结合患者日常生活需求。

特色诊疗 / 中国传统医学

中医特色诊疗

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE



辨证施治 · 兼顾长期管理

中医（Traditional Chinese Medicine, TCM）是中国传统医学的重要组成部分。中心可结合患者需求安排中医辨证评估，将中医治疗与现有疾病管理、康复和用药方案衔接。

可开展的中医方法

中药饮片

中成药

针灸

推拿

拔罐

敷贴

熏蒸

耳穴

个体化评估与疗程

中医医师通过问诊及相应诊察，了解症状、体质、生活方式和病程变化，结合已有现代医学诊断与检查资料制定方案。适合长期管理的患者，可将症状变化、饮食、睡眠及活动情况纳入随访。

与现有治疗衔接

可将中医方法用于适宜的慢性症状、疼痛及恢复需求。请告知全部中西药、过敏及抗凝治疗；同时关注药物相互作用、肝肾功能，明确处方与复诊安排。

中医诊疗场景示意；具体方法按病情及开展条件选择。

感染性疾病与不明原因发热

INFECTION AND FEVER ASSESSMENT



诊疗场景示意

反复发热、复杂感染或免疫功能受损患者的感染，需要结合病程、接触史、既往治疗和检查结果寻找原因。中心根据病情组织感染及相关专业评估，并落实必要的隔离与转诊安排。

治疗与管理相结合

诊疗疾病

- 不明原因或反复发热
- 复杂感染与耐药菌感染
- 真菌感染及重症感染
- 移植、血液病及免疫抑制患者感染

检查与评估

- 旅行、接触与用药史
- 微生物培养及分子检测
- 感染部位、药敏与器官功能
- 影像及感染以外原因评估

治疗项目与手段

1 病因导向治疗

结合病原、药敏、感染部位和既往抗菌药物使用情况，制定有针对性的治疗方案。

2 复杂患者共同管理

免疫功能受损或合并多种疾病时，由感染及相关专业共同评估，关注药物相互作用和器官功能。

3 局部处理与器官支持

按病情评估引流或其他局部处理，危重患者及时衔接监护与器官支持。

4 隔离与转诊

特殊感染性或传染性疾病需隔离治疗；即使已入住中心，仍可能按病原、隔离条件或救治需要转往专门传染病医院。

治疗安排与后续管理

预约时请如实说明近期发热、接触史、已知传染性疾病及耐药菌结果。出现呼吸困难、低血压或意识变化，应及时急诊就医。

重大手术与危重症支持

SURGERY AND CRITICAL CARE SUPPORT



诊疗场景示意

复杂手术和危重症治疗需要手术、麻醉、监护及相关专科共同参与。中心按照患者病情衔接治疗场所与照护资源，在稳定后继续安排康复、基础疾病管理和离院准备。

01 围手术期评估

手术前综合判断心肺、肝肾功能、营养、感染和血栓出血风险，明确麻醉与监护需要。对长期使用抗栓药、降糖药、免疫抑制剂等药物的患者，结合专科意见安排围手术期用药。

02 器官支持与重症救治

医院可根据病情开展机械通气、连续血液净化、血浆置换及相关人工肝支持，符合指征时评估体外膜肺氧合（ECMO）等技术。重症治疗结合血流动力学监测、超声和实验室信息，并同步关注营养、感染及早期康复。

03 公共ICU与专科病区

重大神经、心胸、腹部手术及其他重症情况，可能需要进入医院公共ICU、移植监护或其他专科病区。床位类型与治疗地点由病情和监护条件决定。符合转回标准后，再回中心继续治疗与照护。

04 急性恶化与跨地区转诊

在院期间出现急性变化时，及时启动相应救治与会诊。拟从外地或境外转入的患者，应事先提交近期病情、生命支持及用药资料，由接诊团队评估可行性；转运方式与时机需由负责治疗的医疗团队共同判断。

先进影像与功能检查

IMAGING AND FUNCTIONAL ASSESSMENT



影像检查场景示意

看见结构 理解功能

围绕具体临床问题，选择合适检查。

CT / MRI

结构与专病成像

CT、增强及血管成像；高场强3.0T磁共振与专病序列。按需评估血管壁、多参数或动态功能相关成像。

超声

形态、血流与动态评估

心脏、腹部、甲状腺、乳腺及泌尿等评估；结合造影、弹性、融合影像，可支持移植术前、术中与术后监测。

PET/CT

代谢与综合评估

依据指征开展肿瘤评估、心肌代谢及脑代谢显像，将功能信息与解剖影像相结合。

ECT

灌注与器官功能

SPECT/CT相关心肌灌注、脑血流灌注，以及骨、肾、甲状腺等显像。具体项目结合临床问题与示踪剂条件选择。

其他专病检查包括乳腺摄影、骨密度及相应X线。预约时请说明妊娠可能、植入器械、金属异物及既往对比剂反应。

影像引导操作与精准诊断

IMAGE GUIDED PROCEDURES AND DIAGNOSTICS



病理与检验场景示意

从定位与取材，到病理判断和分子检测，为治疗方案提供依据。

01

影像引导下操作

超声或CT引导下穿刺活检、抽吸、置管引流及适宜的消融。超声可结合造影或融合影像；按病情评估射频、微波等方法。

02

病理与细胞学

组织病理、细胞学、术中冰冻、特殊染色、免疫组化、免疫荧光及原位杂交；疑难病例可安排病理会诊。

03

基因与用药相关检测

按明确指征评估肿瘤分子、特定疾病与个体化用药基因检测；药物浓度及代谢检测可辅助部分免疫抑制剂等药物使用。

04

结果整合与后续安排

血液、生化、免疫、内分泌与微生物检查结合临床解释；中心将重要结果与当前治疗联系，明确未出结果的反馈方式。

请提前咨询病理切片、蜡块、影像原始文件与基因报告的提交方式。

医护照护与语言服务

NURSING LANGUAGE AND PERSONAL SUPPORT



诊疗场景示意

中心的常设医护团队参与日常诊疗、病情观察、用药核对及健康教育，并根据患者的活动能力、病情和沟通需求安排照护与陪同。

01 检查陪同

常规安排工作人员陪同前往检查区域。病情稳定、能够自主行动的患者由普通工作人员陪同；因病情或行动受限，需要专业观察或照护时，经评估安排护士或其他医务人员陪同。

02 中文与英文服务

常规可提供中文和英文服务。其他语言可根据患者需求及实际资源安排，患者也可自备翻译；相关语言服务与自备翻译均无法提供时，主要通过翻译软件辅助沟通。重要病史、用药和治疗决定应确保双方理解一致。

03 护理与生活支持

护理团队结合病情落实治疗配合、用药指导、活动协助、营养与皮肤观察，并评估跌倒等风险。生活协助的范围随病情和自理能力确定；陪护、饮食或其他特殊需要，请在预约或入院时提前说明。

04 隐私与医疗资料

就诊时可说明希望参与沟通的家属或授权联系人。未经许可，请勿拍摄或录制其他患者、医务人员及诊疗活动。常规可提供中英文医疗资料；如需其他语言版本，应提前沟通资料范围、提供方式及准备时间。

从就诊申请到离院随访

YOUR CARE JOURNEY

可直接通过中心电话、邮箱或微信提出咨询。提前提交完整资料，有助于中心判断适合的诊疗路径、需要补充的检查以及来院前准备。

01

来院前提交申请

填写中英文国际患者就诊申请表，说明主要症状、已有诊断、希望解决的问题和计划来院时间，并提供既往病历、影像、病理及用药清单。申请时一并说明语言、行动协助、陪护及其他需求，无需自行决定所有专科安排。

02

评估后确认就诊

中心审核资料，必要时联系患者补充信息，并组织相关专业评估。确认可受理范围后，再沟通门诊或住院安排。持商业保险者请提前提交保险信息，核实保障范围、授权和直付条件；中心不提供保险产品销售。

03

到院诊疗与病情沟通

门诊位于水西院区2层一诊区，住院病区位于16层A/B区。医生根据面诊和补充检查完善方案，必要时调整原安排。住院时按住院证及工作人员指引办理手续，携带身份证件、原始医疗资料和现用药物信息。

04

离院资料与随访

离院时核对诊疗资料、用药和复查安排，说明未出结果的后续反馈方式。短期主要电话随访，长期主要通过邮箱和微信随访，频率根据病情确定。出现急性或明显加重的症状时，应及时在所在地就医，再与中心沟通后续管理。

短期电话随访

长期邮箱与微信随访

频率依病情确定

住院环境与日常照护

INPATIENT ENVIRONMENT AND SUPPORT

水西院区16层A/B区 · 固定病房 · 单人间与套房



部分套房会客空间示意，实际房型与配置以安排为准。

独立空间

独立卫浴、床头呼叫及基本生活设施。部分套房设有会客与陪护空间，房型选择结合病情和实际床位。

陪护与生活

需陪护或临时加床，请提前说明。病区提供病号服和床上用品，清洁、设施维修等可联系工作人员。

饮食与照护

治疗饮食、特殊或宗教饮食需求请提前沟通。护理团队按病情安排用药指导、活动协助及营养和皮肤观察。

治疗场所调整

需要隔离、特殊移植舱或重症监护时，使用相应治疗场所；病情稳定后再评估转回。

详细生活用品、陪护及设施信息，可参阅配套住院指南和病房配置资料。

与我们联系

就诊咨询与资料获取

CONTACT AND PATIENT RESOURCES

就诊预约与综合咨询

+86-022-23628221

工作日 8:00-12:00 / 14:00-17:00

TFCH_interclinic@hotmail.com

邮件通常在48小时内回复

周末及法定节假日

门诊停诊

联系电话 +86-022-23626360

病情紧急时请及时到急诊或联系所在地急救服务。

水西院区

天津市西青区西营门街保山西道2号

门诊：2层一诊区

住院：16层A/B区

国际诊疗中心咨询微信



扫码联系中心

就诊咨询 · 随访沟通 · 意见反馈

扫码联系国际诊疗中心，提出就诊预约、病情咨询、随访沟通及意见反馈，并获取就诊申请表、门诊指南、住院指南和病房配置资料。

首次咨询时，请简要说明主要病情、希望获得的诊疗服务及联系方式。